

1 皮膚障害の薬薬連携 — 予防のスキンケアから

病院薬剤師	病院と共有する情報	保険薬局薬剤師
① 予防内服・保湿剤・外用薬の処方セットの提案	予防の処方セット (保湿剤・予防内服)	① 保湿剤の量・回数・塗り方を実演で説明
② 皮膚症状の評価と休薬・減量の判断支援	皮膚症状の程度 (部位ごと)	② 外用ステロイドの部位別の使い分けを確認
③ 抗EGFR抗体投与時の皮膚症状・Mg値の確認	外用薬の使用量 (残量・塗り方)	③ 保湿剤・外用薬の残量から使用状況を把握
④ 重症薬疹・ICIの皮膚障害への院内対応	Mg値 (抗EGFR抗体)	④ 足の裏の痛み・歩行への支障を聴取(手足症候群)
⑤ 皮膚科への紹介と外用ステロイドのランク調整		⑤ 胃薬・サプリなど他院処方・市販薬の相互作用確認

2 予防と治療 — 皮膚障害の型で使い分ける

ざ瘡様皮疹(EGFR阻害薬) 予防(治療開始時から) 保湿・日焼け止め、テトラサイクリン系の予防内服 症状が出た時 部位に応じた強さの外用ステロイド 薬剤師の確認ポイント 予防内服の服用状況、ミノサイクリンのめまい・色素沈着	爪囲炎 予防(治療開始時から) 深爪を避け、爪の周りへの刺激を減らす 症状が出た時 外用ステロイド、テーピング、皮膚科での処置 薬剤師の確認ポイント 痛み・歩行への影響、皮膚科受診の要否	手足症候群 予防(治療開始時から) 保湿剤、圧迫・摩擦・熱を避ける、厚い角質の事前ケア 症状が出た時 強めの外用ステロイド、休薬・減量 薬剤師の確認ポイント 保湿の回数(1日2回以上)、靴・家事の工夫
皮膚乾燥・亀裂 予防(治療開始時から) 入浴後すぐの保湿 症状が出た時 亀裂にはワセリン等で保護 薬剤師の確認ポイント 亀裂・びらんには尿素製剤は刺激になるため見直し	ICIの皮疹・かゆみ 予防(治療開始時から) 保湿 症状が出た時 外用ステロイド・抗ヒスタミン薬 薬剤師の確認ポイント 粘膜症状・水疱は重症薬疹を疑い即受診	

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サプリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
注意 添付文書 併用注意	ゲフィチニブ・エルロチニブ 胃内pH上昇で吸収低下	処方薬 市販薬 PPI・H2ブロッカー	血中濃度↓ → 効果減弱	市販の胃薬も含めて確認
注意 添付文書 併用注意	エルロチニブ CYP1A2誘導	生活習慣 喫煙	血中濃度↓	喫煙状況を確認し禁煙を支援
注意 添付文書 併用注意	ミノサイクリン(皮疹の予防内服) キレート形成	処方薬 市販薬 サプリ・食品 鉄剤・制酸剤・カルシウム	吸収↓ → 予防効果の減弱	服用時間をずらすよう指導
注意 添付文書 警告	カペシタビン ワルファリンの代謝を阻害	処方薬 ワルファリン	PT-INR↑ → 出血	他院処方を確認し、INRの測定を処方医と共有
注意 添付文書 併用注意	レゴラフェニブ・ソラフェニブ等 CYP3A4誘導	サプリ・食品 セイヨウオトギリソウ	血中濃度↓ → 効果減弱	サプリメントの使用を確認

4 服薬指導タイムライン(声かけ例)

① 治療開始前	② 開始～2週	③ 1～2か月	④ 随時
“皮膚の症状は、予防のスキンケアを早く始めるほど軽くすみます。今日から保湿を習慣にしましょう”	“顔や胸にニキビのような発疹が出て、自己判断で薬をやめず、塗り薬を使ってください”	“爪の周りの腫れや痛み、手足のひび割れはありませんか”	“熱を伴う発疹や、目の充血・口のただれがあれば、すぐに連絡してください”
✓薬局で確認 お薬手帳でレジメン、予防内服・保湿剤・外用薬の処方と量	✓薬局で確認 皮疹・手足の発赤の有無、外用ステロイドの部位別の使い分け	✓薬局で確認 爪囲炎・乾燥・亀裂、保湿剤・外用薬の残量から使用状況を把握	✓薬局で確認 新たに始めた薬(他院処方・市販薬)の有無
△ここに注意 保湿剤の量と回数を実演で説明	△ここに注意 足の裏の痛みで歩きにくい時は連絡	△ここに注意 亀裂への尿素製剤は刺激になるため見直し	△ここに注意 粘膜症状・水疱は重症薬疹を疑い即受診